

Estações pediatria

OSCE HAM III

Monitora: Marysoll Quental

SOBRE ESSE MATERIAL

- Serão apresentados exemplos de estações referentes a cada aula do semestre. Há temas, como doenças exantemáticas, que há um leque de possibilidades, mas nesse material possui apenas uma estação modelo de cada assunto.
- Ao final de cada cenário, haverá um gabarito comentado com os itens esperados na resposta e checklist em comandos práticos.

DICA DE ESTUDO

A estação pode ser:

- Somente oral;
- Somente prática;
- Ou uma combinação de perguntas orais e atividades práticas.

Uma boa **estratégia de estudo** é organizar cada patologia seguindo um mesmo raciocínio:

1. Manifestações Clínicas

- Quais são os sinais e sintomas da doença?
- A questão pode apresentar as manifestações clínicas e pedir a identificação da patologia, inclusive solicitar perguntas importantes que deveriam ter na anamnese desse paciente.
- Outra maneira é apresentar a patologia e solicitar suas manifestações clínicas.

2. Diagnóstico

- O diagnóstico é apenas clínico ou necessita de exames complementares?
- Quais exames devem ser solicitados?
- Como interpretar ou justificar a solicitação desses exames?

3. Tratamento

- Quais medidas farmacológicas devem ser indicadas?
- Quais medidas não farmacológicas são recomendadas?
- Como orientar o paciente adequadamente?

4. **Exame Físico**

- O que deve ser avaliado diante da suspeita da doença?
- Quais manobras ou achados são mais importantes?
- Como realizar o exame físico de forma sistematizada?

Seguir esse esquema para cada tema facilita a construção de uma linha de raciocínio organizada para cada patologia.

LISTA DE CONTEÚDOS

- Entrevista clínica do paciente pediátrico;
- Exame físico geral da criança;
- Técnicas de aferição e interpretação da pressão arterial na criança;
- Crescimento e desenvolvimento
- Insuficiência cardíaca na criança;
- Maus-tratos na infância;
- Cardiopatias congênitas;
- Valvulopatias;
- Pericardite na criança;
- Tuberculose Pulmonar;
- Asma na infância;
- Sinusopatias;
- Pneumonia na infância;
- Exame físico do sistema hemolinfopoiético na infância;
- Oncologia e o sistema hemolinfopoiético na infância.
- Doenças exantemáticas e lesões elementares de pele.

CENÁRIO 1

Você atende uma criança de 4 anos trazida pela mãe devido a febre há 3 dias e redução do apetite.

A) Cite três perguntas que você considera essenciais para investigar a queixa atual.

B) Cite três informações da história pregressa que não podem ser esquecidas na consulta pediátrica.

C) Cite três orientações para melhorar a comunicação com a criança e seu responsável durante a consulta.

GABARITO CENÁRIO 1

Cenário referente a aula ANAMNESE DO PACIENTE PEDIÁTRICO.

A) Cite três perguntas que você considera essenciais para investigar a queixa atual.

Quando a febre começou? Qual a temperatura máxima aferida?

Há outros sintomas associados?

A criança está aceitando alimentação?

Houve contato com pessoas doentes?

Foi utilizada alguma medicação?

Como está a ingestão de líquidos?

O objetivo é caracterizar a história da doença atual.

B) Cite três informações da história pregressa que não podem ser esquecidas.

Estado vacinal.

Antecedentes gestacionais e perinatais.

Internações prévias.

Cirurgias.

Alergias.

Uso contínuo de medicamentos.

Desenvolvimento neuropsicomotor.

C) Cite três orientações para melhorar a comunicação durante a consulta.

Apresentar-se à criança e ao responsável.

Utilizar linguagem adequada à faixa etária.

Escutar atentamente as preocupações dos responsáveis.

Manter contato visual. Evitar termos excessivamente técnicos.

Envolver a criança na consulta quando possível

Em pediatria, a consulta é centrada na criança, mas frequentemente mediada pelo responsável.

CENÁRIO 2

Você está atendendo uma lactente de 8 meses em consulta de puericultura.

A) Cite pelo menos duas medidas antropométricas que devem ser obtidas rotineiramente nessa consulta e duas circunferências que podem complementar a avaliação nutricional.

B) Demonstre como realizar a medida do perímetro cefálico.

GABARITO CENÁRIO 2

Cenário referente a aula EXAME FÍSICO PEDIÁTRICO

A) Cite pelo menos duas medidas antropométricas que devem ser obtidas rotineiramente nessa consulta e duas circunferências que podem complementar a avaliação nutricional.

Medidas antropométricas básicas:

Peso. Comprimento. Perímetro cefálico.

Circunferências complementares:

Circunferência braquial. Circunferência abdominal.

Essas medidas permitem avaliar crescimento, desenvolvimento e estado nutricional da criança.

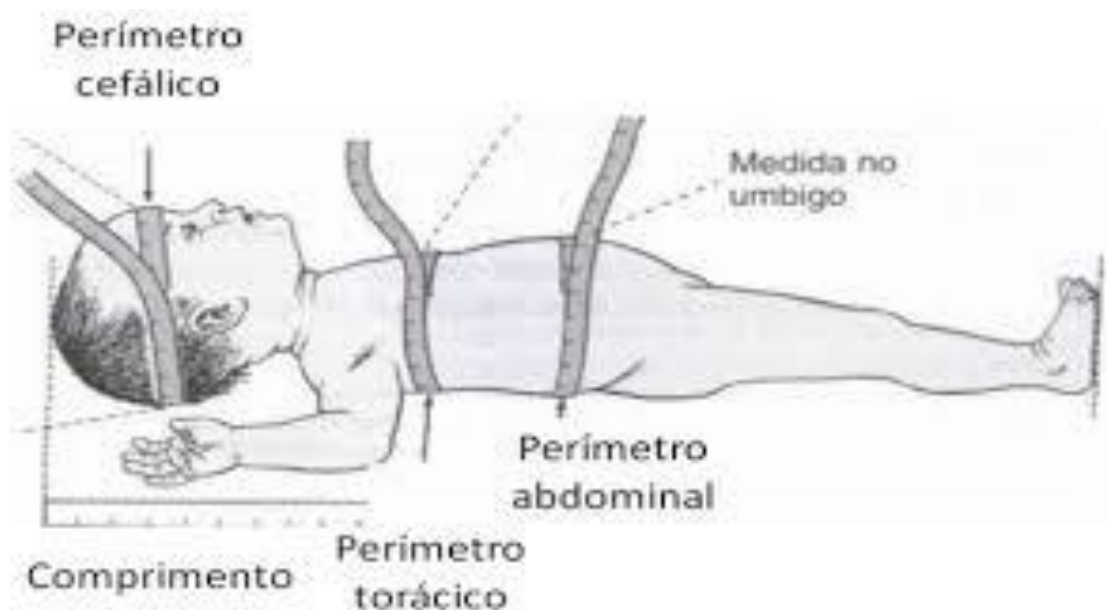
B) Demonstre como realizar a medida do perímetro cefálico.

Posicionar a fita acima das sobrancelhas (região supraorbital).

Passar a fita pela maior proeminência occipital.

Manter a fita ajustada e nivelada.

Realizar a leitura em centímetros.



Pontos-chave para avaliação:

Identificação correta dos pontos anatômicos.

Posicionamento adequado da fita.

Técnica cuidadosa e organizada.

Checklist

- Se apresentar como médico.
- Considerar mãos e materiais higienizados.
- Considerar ambiente confortável, iluminação adequada, ar-condicionado desligado.
- Solicitar para a mãe ficar próxima durante a avaliação.
- Realizar a técnica correta.

CENÁRIO 3

Você está atendendo uma criança de 4 anos em consulta de rotina.

A) Demonstre a técnica correta para aferição da pressão arterial em uma criança.

B) A pressão arterial aferida foi de 108/70 mmHg. Considerando uma menina de 4 anos com estatura no percentil 50, utilize a tabela simplificada fornecida para classificar a pressão arterial.

Classificação	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	
Percentil 50	92	53	
Percentil 90	106	65	
Percentil 95	109	69	
Percentil 95 + 12 mmHg	121	81	

GABARITO CENÁRIO 3

Cenário referente a aula AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NA CRIANÇA.

A) Demonstre a técnica correta para aferição da pressão arterial em uma criança.

Apresentar-se e explicar o procedimento à criança e ao responsável.

Garantir repouso prévio de pelo menos 5 minutos, em ambiente tranquilo.

- Posicionar adequadamente a criança:

Sentada. Costas apoiadas. Pés apoiados no chão ou em suporte.

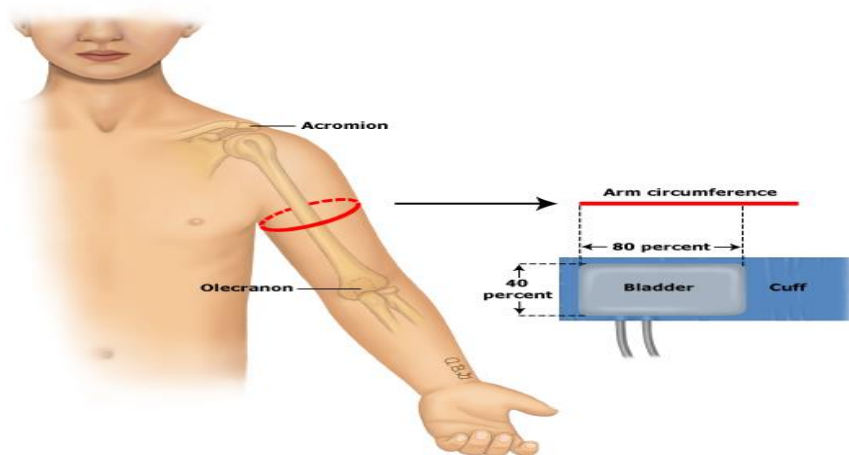
Pernas descruzadas. Sem falar durante a medida.

- Escolher o manguito adequado:

A largura da bolsa inflável deve corresponder a aproximadamente 40% da circunferência do braço.

O comprimento da bolsa deve envolver 80 a 100% da circunferência do braço.

O uso de manguito inadequado é uma das principais causas de erro na medida.



- Posicionar o braço:

Sem roupas comprimindo o membro. Relaxado. Apoiado. Na altura do coração.

- Posicionar o manguito:

Cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital.

Com a marca da artéria braquial alinhada à artéria braquial.

Palpar a artéria braquial na fossa antecubital.

Insuflar o manguito até cerca de 20 a 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial (ou do valor sistólico estimado).

Desinsuflar lentamente (aproximadamente 2 a 3 mmHg por segundo), auscultando os sons de Korotkoff.

- Registrar os valores:

Primeiro som de Korotkoff = Pressão Arterial Sistólica (PAS).

Desaparecimento dos sons (fase V) = Pressão Arterial Diastólica (PAD).

Registrar o resultado em mmHg, informando o braço utilizado.

B) A pressão arterial aferida foi de 108/70 mmHg. Considerando uma menina de 4 anos com estatura no percentil 50, utilize a tabela fornecida para classificar a pressão arterial.

PAS = 108 mmHg → entre P90 e P95.

PAD = 70 mmHg → acima do P95 (69 mmHg).

Pela diretriz pediátrica, a classificação é feita pelo valor mais elevado (sistólico ou diastólico).

Como basta um dos componentes (PAS ou PAD) estar $\geq$ P95 para a classificação, a criança apresenta hipertensão arterial estágio 1.

Crianças de 1 a 13 anos de idade	Crianças com idade ≥ 13 anos
Normotensão: PA < P90 para sexo, idade e altura	Normotensão: PA < 120/<80 mmHg
Pressão arterial elevada: PA $\geq$ P90 e < P95 para sexo, idade e altura ou PA 120/80 mmHg mas < P95 (o que for menor)	Pressão arterial elevada: PA 120/<80 mmHg a PA 129/<80 mmHg
Hipertensão estágio 1: PA $\geq$ P95 para sexo, idade e altura até <P95 + 12mmHg ou PA entre 130/80 o até 139/89 (o que for menor)	Hipertensão estágio 1: PA 130/80 ou até 139/89
Hipertensão estágio 2: PA $\geq$ P95 + 12mmHg para sexo idade ou altura ou PA $\geq$ entre 140/90 (o que for menor)	Hipertensão estágio 2: PA $\geq$ entre 140/90

Checklist

Se apresentar como médico.

Considerar mãos e materiais higienizados.

Ambiente confortável.

Explicou o procedimento ao responsável e criança.

Posicionou adequadamente a criança.

Escolheu o manguito correto.

Manteve o braço na altura do coração.

Executou corretamente a técnica de aferição.

Localizou os valores no gráfico de percentis.

Classificou corretamente a pressão arterial.

CENÁRIO 4

Durante uma consulta de puericultura, a mãe de uma criança de 10 meses relata:

"Doutor(a), minha filha ainda não anda. Ela senta sozinha, engatinha pela casa toda, pega brinquedos com as mãos e fala apenas 'mamama' e 'papapa'. Estou preocupada. Isso é normal para a idade?"

A) Avalie se o desenvolvimento da criança é compatível com a idade e justifique sua resposta.

B) Cite dois marcos do desenvolvimento esperados para uma criança de 10 meses.

GABARITO CENÁRIO 4

Cenário referente a aula de CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

A) Avalie se o desenvolvimento da criança é compatível com a idade e justifique sua resposta.

Sim, o desenvolvimento é compatível com a idade.

A criança:

Senta sem apoio.

Engatinha.

Manipula objetos.

Emite sílabas repetidas ("mamama", "papapa").

Esses achados são compatíveis com os marcos esperados para 10 meses. Não se espera que todas as crianças andem nessa idade.

B) Cite dois marcos do desenvolvimento esperados para uma criança de 10 meses.

Possíveis respostas:

Senta sem apoio.

Engatinha ou se locomove pelo ambiente.

Fica em pé com apoio.

Pega objetos utilizando pinça (início da pinça fina).

Transfere objetos de uma mão para outra.

Balbucia sílabas repetidas.

Reconhece pessoas familiares.

Checklist

- ☐ Reconheceu que a criança apresenta desenvolvimento compatível com a idade.
- ☐ Justificou utilizando os marcos apresentados pela mãe.
- ☐ Explicou que a marcha independente ainda não é obrigatória aos 10 meses.
- ☐ Citou dois marcos adequados para a faixa etária.

TABELA DE MARCOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: GUIA GERAL

1	2	3	4	5
0-3 Meses	3-6 Meses	6-12 Meses	1-2 Anos	2-3 Anos
- Sustenta a cabeça brevemente - Sorri socialmente - Movimentos reflexos - Segue objetos com o olhar	- Rola de bruços para as costas - Senta com apoio - Agarra objetos com as duas mãos - Balbucia 'ba-ba', 'ma-ma'	- Engatinha - Fica em pé apoiado - Faz a 'pinça' com os dedos - Acena 'tchau'	- Anda sozinho - Fala 5-10 palavras simples - Empilha 2-3 blocos - Aponta para objetos	- Corre e pula - Usa frases de 2-3 palavras - Empilha 6-8 blocos - Desenha traços e círculos

Normalidade

Common variações

Consulta o pediatra para não-progressão

Lembre-se: Cada criança tem seu próprio ritmo. Estas são médias gerais. Consulte o pediatra se houver preocupações persistentes.

CENÁRIO 5

A mãe de um lactente de 4 meses relata:

Meu filho cansa muito durante as mamadas. Ele mama por pouco tempo, começa a suar bastante na cabeça e parece ficar cansado. Também percebi que ele não está ganhando peso como antes e está respirando mais rápido.

A) Realize a palpação do fígado para pesquisa de hepatomegalia.

B) Considerando a história clínica apresentada, qual o principal diagnóstico sintomático apresentado pela criança?

GABARITO CENÁRIO 5

Cenário referente a aula INSUFICIENCIA CARDIACA NA CRIANÇA

A) Realize a palpação do fígado para pesquisa de hepatomegalia.

Não existe um nome exclusivo ou diferente apenas para as crianças, mas a semiologia pediátrica utiliza as mesmas manobras clássicas consagradas na medicina adulta. As duas principais técnicas de palpação do fígado utilizadas por pediatras são a Manobra de Lemos Torres (técnica unimanual ou bimanual de apoio) e a Manobra de Mathieu (técnica em garra)

Possível manobra:

Lemos Torres:

Posicione a criança em decúbito dorsal, com o abdome exposto e relaxado.

Coloque-se à direita da criança.

Mão esquerda: posicione-a por trás do paciente, na região lombar direita (loja renal direita), como se estivesse "levantando" o fígado em direção à parede abdominal anterior. Essa mão faz uma pressão suave para frente.

Mão direita: coloque-a espalmada sobre o abdome, abaixo do rebordo costal direito, com os dedos apontando para a cabeça da criança.

Peça uma inspiração profunda (em crianças maiores) ou sincronize a manobra com a inspiração espontânea da criança. Durante a inspiração, o diafragma desce e o fígado também desce.

Enquanto a criança inspira, faça uma pressão suave com as polpas dos dedos da mão direita em direção ao fígado, tentando sentir a borda hepática deslizar sob seus dedos.

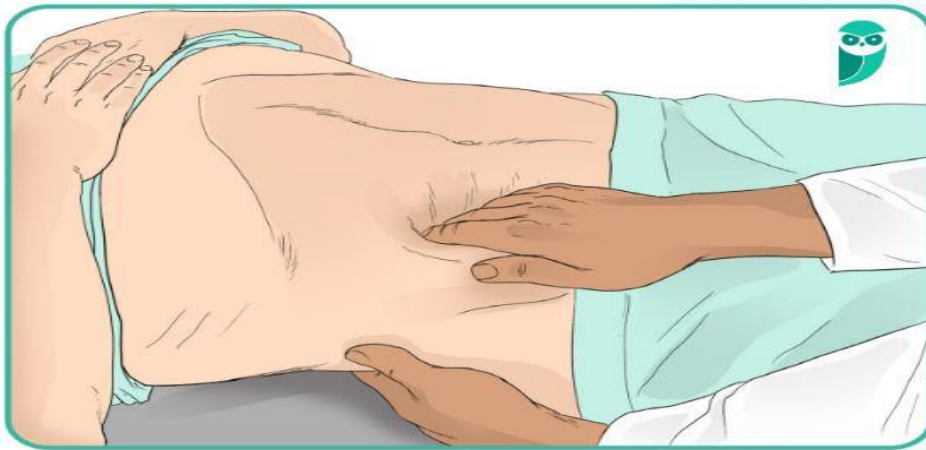
Se palpar a borda hepática, avalie:

Quantos centímetros abaixo do rebordo costal ela se encontra.

Consistência (macia ou endurecida).

Superfície (lisa ou irregular).

Sensibilidade dolorosa



A hepatomegalia é um dos principais achados do exame físico em lactentes com insuficiência cardíaca.

B) Considerando a história clínica apresentada, qual o principal diagnóstico sindrômico apresentado pela criança?

Insuficiência cardíaca.

- Achados que sustentam a hipótese:

Sudorese durante as mamadas.

Cansaço durante a alimentação.

Taquipneia.

Necessidade de interromper as mamadas para descansar.

Baixo ganho ponderal/falha de crescimento.

Irritabilidade.

Redução da atividade habitual.

Em lactentes, a mamada funciona como um verdadeiro "teste de esforço". A associação de fadiga às mamadas, sudorese, taquipneia e baixo ganho de peso é altamente sugestiva de insuficiência cardíaca, frequentemente associada a cardiopatias congênitas com hiperfluxo pulmonar.

Checklist

Se apresentou como médico.

Mãos higienizadas.

Ambiente adequado.

Explicou o procedimento ao responsável.

Solicitar ao acompanhante para ficar próximo.

Solicitar ao responsável para retirar a vestimenta da criança.

Posicionar adequadamente a criança.

Iniciar a palpação.

Executou corretamente a técnica de palpação hepática.

Identificou a pesquisa de hepatomegalia.

Suspeitou de insuficiência cardíaca.

CENÁRIO 6

Uma menina de 6 anos é levada à Unidade de Saúde pela mãe devido a dor no braço após uma suposta queda da cama. Durante o exame físico, você observa múltiplas equimoses em tronco, braços e coxas, algumas com colorações diferentes e em distintos estágios de cicatrização. Ao ser questionada, a mãe apresenta versões diferentes sobre como ocorreram as lesões.

A) Cite três achados da história ou do exame físico que aumentam a suspeita de maus-tratos na infância.

B) Qual deve ser a conduta diante desse caso?

GABARITO CENÁRIO 6

Cenário referente a aula MAUS TRATOS NA INFÂNCIA.

A) Cite três achados da história ou do exame físico que aumentam a suspeita de maus-tratos na infância.

Possíveis respostas:

História incompatível com as lesões encontradas.

Relatos contraditórios do responsável.

Equimoses em diferentes estágios de cicatrização.

Lesões em múltiplas regiões do corpo.

Lesões em áreas pouco usuais para trauma acidental (tronco, face interna das coxas, pescoço, orelhas).

Procura tardia por atendimento.

Comportamento amedrontado ou retraído da criança.

A suspeita de violência deve ser considerada quando os achados clínicos não são compatíveis com a história relatada.

B) Qual deve ser a conduta diante desse caso?

Garantir a segurança e o atendimento da criança.

Registrar detalhadamente os achados da história e do exame físico em prontuário.

Realizar a notificação compulsória de suspeita de violência contra criança e adolescente.

Acionar a rede de proteção da criança conforme o fluxo local (serviço social, Conselho Tutelar e demais órgãos competentes).

Encaminhar para avaliação multiprofissional quando necessário.

Não é necessário que o profissional tenha certeza da ocorrência da violência para notificar. A suspeita já é suficiente para que a notificação seja realizada e a rede de proteção seja acionada.

CENÁRIO 7

A mãe de um lactente de 3 meses relata que a criança apresenta cansaço durante as mamadas, interrupções frequentes para respirar, sudorese excessiva principalmente na cabeça e dificuldade para ganhar peso. Ela refere que esses sintomas vêm piorando nas últimas semanas.

A) Realize a ausculta cardíaca da criança.

B) Considerando a história clínica apresentada, qual a principal hipótese diagnóstica e quais achados sustentam essa hipótese?

GABARITO CENÁRIO 7

Cenário referente a aula CARDIOPATIAS CONGÊNITAS.

A) Realize a ausculta cardíaca da criança.

Explicar o procedimento ao responsável e à criança (quando a idade permitir).

Posicionar a criança de forma confortável:

Lactentes: preferencialmente no colo do responsável ou em decúbito dorsal.

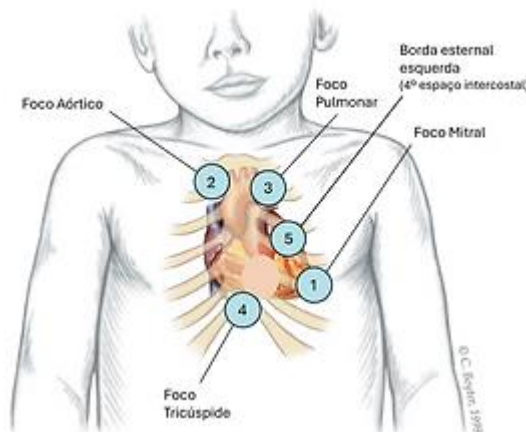
Crianças maiores: sentadas ou em decúbito dorsal.

Aquecer o diafragma do estetoscópio antes do contato.

Expor adequadamente o tórax.

Auscultar sistematicamente os focos cardíacos:

Foco	Localização
Aórtico	2º espaço intercostal direito, junto ao esterno
Pulmonar	2º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno
Tricúspide	Borda esternal inferior esquerda (4º-5º EIC)
Mitral	5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular (ou localização correspondente à idade)



Em cardiopatias congênicas, a ausculta pode revelar sopros cardíacos sugestivos de defeitos estruturais.

B) Considerando a história clínica apresentada, qual a principal hipótese diagnóstica e quais achados sustentam essa hipótese?

Cardiopatía congênita (não precisa especificar qual é porque depende de exames.)

- Achados que sustentam a hipótese:

Cansaço durante as mamadas.

Sudorese durante a alimentação.

Pausas frequentes para respirar.

Baixo ganho ponderal.

Piora progressiva dos sintomas após os primeiros meses de vida.

O quadro é típico de cardiopatias congênitas que evoluem com insuficiência cardíaca após a queda da resistência vascular pulmonar, geralmente entre 1 e 3 meses de vida. A comunicação interventricular (CIV) é uma das causas clássicas desse quadro.

Checklist

Se apresentou como médico.

Mãos e materiais higienizados.

Ambiente adequado.

Solicitou a mãe para retirar vestimenta e ficar próxima.

Explicou o procedimento.

Esquentou o estetoscópio.

Realizou ausculta nos focos cardíacos principais.

Suspeitou de cardiopatía congênita.

Relacionou os achados clínicos à hipótese diagnóstica.

CENÁRIO 8

A mãe de uma lactente de 6 meses relata que a filha apresenta episódios em que fica "arroxeadada" durante as mamadas e quando chora intensamente. Refere também cansaço durante a alimentação, sudorese excessiva e dificuldade para ganhar peso. Os sintomas vêm sendo percebidos desde os primeiros meses de vida.

A) Cite três perguntas importantes que devem ser realizadas durante a anamnese.

B) Qual a principal hipótese diagnóstica?

C) Quais exames complementares devem ser solicitados para investigação?

GABARITO CENÁRIO 8

Cenário referente a aula VALVULOPATIAS.

A) Cite três perguntas importantes que devem ser realizadas durante a anamnese.

Possíveis respostas:

A cianose ocorre apenas durante as mamadas ou também em repouso?

A criança apresenta cansaço ou interrupções frequentes durante as mamadas?

Há dificuldade para ganhar peso?

Os episódios de cianose melhoram espontaneamente?

A criança apresenta taquipneia?

Os sintomas estão presentes desde o nascimento?

Existe história familiar de cardiopatia congênita?

O objetivo é caracterizar a cianose e avaliar sinais de repercussão cardiovascular.

B) Qual a principal hipótese diagnóstica?

Cardiopatia congênita cianogênica/ valvulopatia congênita.

A presença de cianose durante mamadas, associada a sudorese, fadiga alimentar e baixo ganho ponderal, sugere cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Embora a estação seja de valvulopatia, o aluno deve reconhecer o quadro sindrômico.

C) Quais exames complementares devem ser solicitados para investigação?

Ecocardiograma (principal exame).

Eletrocardiograma.

Radiografia de tórax.

CENÁRIO 9

Um menino de 12 anos é levado ao pronto atendimento com dor torácica há 2 dias. Refere dor em pontada, que piora ao respirar profundamente e quando se deita. Relata melhora ao sentar-se e inclinar o tronco para frente. A mãe informa que ele apresentou um quadro gripal há aproximadamente uma semana.

A) Cite três características da história clínica que aumentam a suspeita de pericardite.

B) Qual achado você espera encontrar na ausculta cardíaca desse paciente?

C) Qual exame deve ser solicitado para avaliar a presença de derrame pericárdico?

GABARITO CENÁRIO 9

Cenário referente a aula PERICARDITE

A) Cite três características da história clínica que aumentam a suspeita de pericardite.

Possíveis respostas:

Dor torácica que piora com a inspiração.

Dor que piora ao deitar.

Dor que melhora ao sentar-se e inclinar-se para frente.

História recente de infecção viral.

Dor de característica pleurítica.

B) Qual achado você espera encontrar na ausculta cardíaca desse paciente?

Atrito pericárdico.

O atrito pericárdico ocorre pelo contato entre os folhetos inflamados do pericárdio e é considerado um dos achados mais característicos da doença.

C) Qual exame deve ser solicitado para avaliar a presença de derrame pericárdico?

Ecocardiograma.

O ecocardiograma é o exame de escolha para identificar e quantificar o derrame pericárdico, além de avaliar sua repercussão hemodinâmica e detectar sinais de tamponamento cardíaco.

CENÁRIO 10

Uma criança de 7 anos é levada à Unidade de Saúde por apresentar tosse há aproximadamente 6 semanas. A mãe refere febre baixa no final da tarde, perda de peso, diminuição do apetite e cansaço. Durante a consulta, informa que o pai foi diagnosticado com tuberculose pulmonar há 2 meses e mora na mesma residência.

A) Cite três achados da anamnese que aumentam a suspeita de tuberculose pulmonar.

B) Além da radiografia de tórax, cite dois exames ou testes importantes para investigação diagnóstica.

C) Qual primeira conduta deve ser feita em casos de Tuberculose?

GABARITO CENÁRIO 10

Cenário referente a aula TUBERCULOSE PULMONAR.

A) Cite três achados da anamnese que aumentam a suspeita de tuberculose pulmonar.

Possíveis respostas:

Tosse persistente por mais de 4 semanas.

Contato domiciliar com paciente portador de tuberculose.

Febre vespertina.

Perda de peso.

Inapetência.

Cansaço/astenia.

B) Além da radiografia de tórax, cite dois exames ou testes importantes para investigação diagnóstica.

Possíveis respostas:

Teste tuberculínico (PPD).

Teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB/GeneXpert).

Baciloscopia (quando possível).

Cultura para micobactérias.

Na infância, o diagnóstico costuma ser baseado na soma de critérios clínicos, epidemiológicos, radiológicos e laboratoriais.

C) Qual primeira conduta deve ser feita antes de iniciar o tratamento da Tuberculose?

Notificação compulsória

CENÁRIO 11

Uma criança de 7 anos é levada à consulta pela mãe. Ela relata que o filho apresenta episódios frequentes de tosse seca durante a madrugada, chiado no peito após correr e falta de ar quando tem gripe. Os sintomas melhoram após uso de bombinha prescrita anteriormente.

A) Cite três perguntas importantes que devem ser realizadas durante a anamnese.

B) Cite três fatores que podem desencadear crises asmáticas.

C) Qual orientação deve ser fornecida à família para ajudar no controle da doença?

GABARITO CENÁRIO 11

Cenário referente a aula ASMA

A) Cite três perguntas importantes que devem ser realizadas durante a anamnese.

Possíveis respostas:

Os sintomas acordam a criança durante a noite?

Com que frequência ocorrem os episódios de chiado?

Há limitação para atividades físicas?

Já precisou ir à emergência por falta de ar?

Existe uso frequente de broncodilatador?

Há história pessoal ou familiar de alergias, rinite ou dermatite atópica?

B) Cite três fatores que podem desencadear crises asmáticas.

Possíveis respostas:

Infecções virais.

Poeira domiciliar.

Mofo.

Fumaça de cigarro.

Pelos de animais.

Mudanças climáticas.

Exercício físico.

Cheiros fortes.

C) Qual orientação deve ser fornecida à família para ajudar no controle da doença?

Possíveis respostas:

Evitar exposição à fumaça de cigarro.

Reduzir contato com poeira e mofo.

Manter acompanhamento médico regular.

Utilizar corretamente as medicações prescritas.

Reconhecer sinais de agravamento e procurar atendimento quando necessário.

CENÁRIO 12

Uma criança de 9 anos é levada à consulta pela mãe devido a congestão nasal persistente. Ela relata que o filho teve um quadro gripal há cerca de duas semanas e parecia estar melhorando, mas nos últimos 3 dias voltou a apresentar febre, aumento da secreção nasal amarelada e piora da tosse, principalmente à noite.

A) Cite três achados da anamnese que chamam atenção nesse caso.

B) Qual característica da evolução clínica sugere rinossinusite bacteriana em vez de um resfriado comum?

GABARITO CENÁRIO 12

Cenário referente a aula SINUSOPATIAS.

A) Cite três achados da anamnese que chamam atenção nesse caso.

Possíveis respostas:

Congestão nasal persistente.

Secreção nasal amarelada.

Tosse predominante noturna.

Retorno da febre.

Piora dos sintomas após melhora inicial.

Sintomas com mais de 10 dias de evolução.

Todos esses elementos devem aumentar a suspeita de rinossinusite bacteriana.

B) Qual característica da evolução clínica sugere rinossinusite bacteriana em vez de um resfriado comum?

Piora dos sintomas após melhora inicial ("dupla piora").

Aceitar também:

Persistência dos sintomas por mais de 10 dias sem melhora.

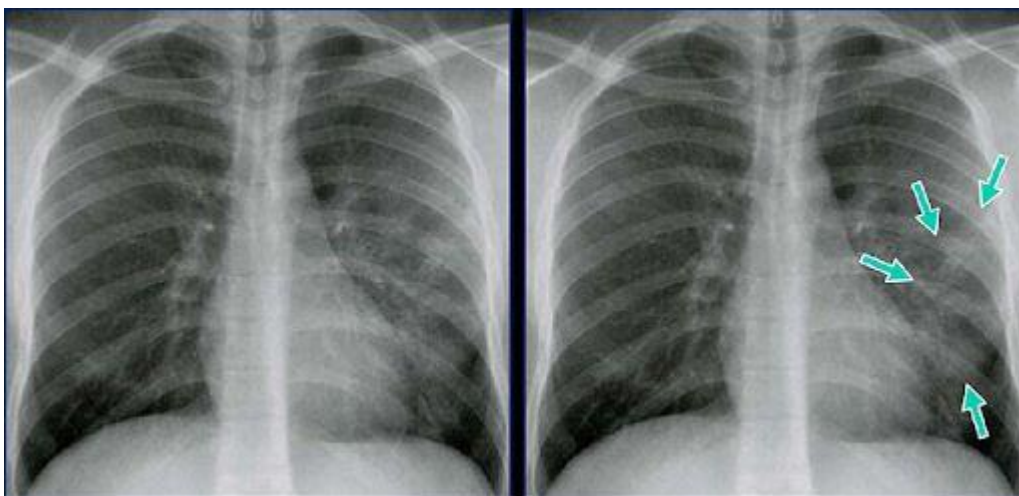
A dupla piora é um dos critérios clássicos para diagnóstico clínico de rinossinusite bacteriana aguda.

CENÁRIO 13

Uma criança de 5 anos é levada ao pronto atendimento com febre há 4 dias, tosse produtiva e dificuldade para respirar. A mãe relata diminuição do apetite e cansaço para brincar. Ao exame inicial, a criança apresenta taquipneia.

A) Demonstre como realizar a avaliação da frequência respiratória em uma criança.

B) Observe a radiografia de tórax fornecida. Cite um achado radiológico compatível com sua suspeita.



C) Qual a principal hipótese diagnóstica?

GABARITO CENÁRIO 13

Cenário referente a aula PNEUMONIA

A) Demonstre como realizar a avaliação da frequência respiratória em uma criança.

Observar os movimentos torácicos ou abdominais sem notificar a criança o que você está realizando.

Contar os movimentos respiratórios durante 1 minuto completo.

Evitar realizar a contagem enquanto a criança chora ou está agitada.

Informar o valor encontrado e compará-lo com a faixa etária.

A taquipneia é um dos sinais mais importantes para suspeita de pneumonia na infância.

B) Observe a radiografia de tórax fornecida. Cite um achado radiológico compatível com sua suspeita.

Consolidação pulmonar.

O achado clássico é uma área de consolidação pulmonar compatível com processo infeccioso.

C) Qual a principal hipótese diagnóstica?

Pneumonia adquirida na comunidade.

A associação de febre, tosse, dificuldade respiratória, taquipneia e alteração radiológica é sugestiva de pneumonia.

CENÁRIO 14

Uma criança de 7 anos é levada à consulta devido ao aparecimento de "ínguas" no pescoço há cerca de 2 semanas. A mãe refere que a criança teve um quadro de infecção de vias aéreas superiores recentemente e está sem febre no momento.

A) Realize o exame físico dos linfonodos cervicais.

B) Durante a avaliação dos linfonodos, quais características devem ser descritas?

C) Cite dois órgãos que também devem ser avaliados no exame físico do sistema hemolinfopoiético.

GABARITO CENÁRIO 14

Cenário referente a aula EXAME FÍSICO DO SISTEMA HEMOLINFOPOIÉTICO

A) Realize o exame físico dos linfonodos cervicais.

Explicar o procedimento ao paciente/responsável.

Posicionar a criança sentada.

Utilizar as polpas digitais dos dedos indicador e médio.

- Palpar de forma suave e sistemática as cadeias:

Submentoniana.

Submandibular.

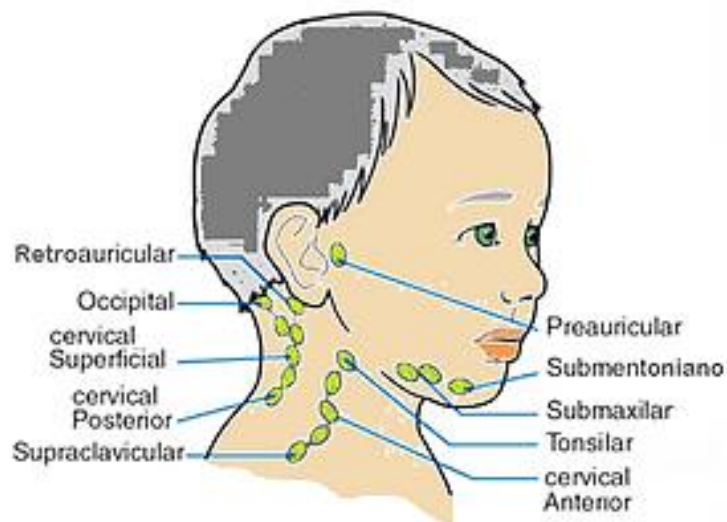
Cervical anterior.

Cervical posterior.

Supraclavicular.

Occipital (quando pertinente).

Comparar ambos os lados.



A palpação deve ser bilateral e organizada.

B) Durante a avaliação dos linfonodos, quais características devem ser descritas?

Localização.

Tamanho.

Consistência.

Mobilidade.

Sensibilidade dolorosa.

Número de linfonodos.

Presença de aderência aos planos profundos.

Essas características ajudam a diferenciar linfonodomegalias reacionais de causas mais graves.

C) Cite dois órgãos que também devem ser avaliados no exame físico do sistema hemolinfopoiético.

Baço.

Fígado.

A pesquisa de hepatomegalia e esplenomegalia é fundamental na avaliação hemolinfopoiética.

Checklist

Se apresentou como médico.

Mãos higienizadas.

Ambiente adequado.

Explicou o procedimento.

Esquentou as mãos antes de tocar no paciente.

Palpou as cadeias cervicais de forma sistemática.

Utilizou técnica adequada de palpação.

Comparou os dois lados.

Citou características importantes dos linfonodos.

Reconheceu a importância da avaliação do fígado e do baço.

CENÁRIO 15

Uma criança de 6 anos é levada à consulta devido a cansaço progressivo há cerca de 2 meses. A mãe relata que a criança está mais pálida, apresenta febre baixa intermitente, perda de apetite e episódios de dor óssea (“dor nas pernas”) principalmente à noite. Refere também surgimento de “ínguas” no pescoço e abaixo das axilas.

A) Cite três achados da história clínica que chamam atenção para uma possível doença onco-hematológica.

B) Descreva o que deve ser observado na palpação dos linfonodos.

C) Qual a principal hipótese diagnóstica e qual deve ser a conduta inicial?

GABARITO CENÁRIO 15

Cenário referente a aula ONCOLOGIA E SISTEMA HEMATOLINFOPOIÉTICO

A) Cite três achados da história clínica que chamam atenção para uma possível doença onco-hematológica.

Possíveis respostas:

Palidez progressiva (sugestiva de anemia).

Febre baixa prolongada ou intermitente.

Perda de peso e inapetência.

Dor óssea (principalmente noturna).

Linfonodomegalias em múltiplas regiões.

Cansaço/fadiga importante.

Sangramentos ou equimoses (se presentes).

A associação de sintomas sistêmicos com linfonodomegalias e dor óssea levanta forte suspeita de doença hematológica maligna, como leucemia.

B) Descreva o que deve ser observado na palpação dos linfonodos.

Avaliar características dos linfonodos:

Tamanho.

Consistência (amolecido, firme, endurecido).

Mobilidade (móvel ou fixo).

Sensibilidade dolorosa.

Aderência a planos profundos.

Número e distribuição.

Linfonodos endurecidos, fixos, indolores e em múltiplas cadeias aumentam suspeita de malignidade.

C) Qual a principal hipótese diagnóstica e qual deve ser a conduta inicial?

Leucemia aguda (principalmente leucemia linfoblástica aguda na infância).

Conduta inicial:

Solicitar hemograma completo com avaliação de série vermelha, branca e plaquetas.

Encaminhar com urgência para serviço de hematologia pediátrica.

Avaliação hospitalar para investigação complementar (mielograma se indicado).

Não retardar encaminhamento diante de forte suspeita clínica.

A leucemia é a neoplasia mais comum na infância, e o diagnóstico precoce depende do reconhecimento de sinais clínicos inespecíficos, como palidez, febre persistente e linfonodomegalias.

CENÁRIO 16

Uma criança de 4 anos é levada à unidade de saúde com febre alta há 4 dias associada a tosse, coriza intensa e conjuntivite. A mãe relata que, há 1 dia, surgiram manchas avermelhadas na pele que começaram no rosto e se espalharam para o corpo. A criança não possui esquema vacinal completo.



A) Cite três achados clínicos presentes no caso que são sugestivos do diagnóstico.

B) Classifique o tipo de lesão cutânea observada nas imagens e descreva suas características.

C) Qual a principal hipótese diagnóstica e qual a conduta imediata?

GABARITO CENÁRIO 16

Cenário referente a aula DOENÇAS EXANTEMATOSAS E LESÕES ELEMENTARES DE PELE

A) Cite três achados clínicos presentes no caso que são sugestivos do diagnóstico.

Possíveis respostas:

Febre alta associada ao exantema.

Tosse, coriza e conjuntivite (tríade clássica de pródromos respiratórios).

Exantema que iniciou na face e se espalhou para o corpo (padrão cefalocaudal).

Esquema vacinal incompleto.

Manchas cutâneas disseminadas após pródromos.

O conjunto de pródromos respiratórios + exantema cefalocaudal é altamente sugestivo de sarampo.

B) Classifique o tipo de lesão cutânea observada nas imagens e descreva suas características.

Exantema maculopapular.

Características:

Máculas e pápulas eritematosas.

Distribuição cefalocaudal.

Confluência progressiva das lesões.

Início na face com progressão para tronco e membros.

O sarampo apresenta exantema típico maculopapular que se dissemina de forma descendente.

C) Qual a principal hipótese diagnóstica e qual a conduta imediata?

Sarampo.

Conduta:

Isolamento respiratório imediato.

Notificação compulsória.

Suporte clínico (hidratação e antitérmicos).

Avaliação e bloqueio vacinal de contatos.

Comunicação à vigilância epidemiológica.

O sarampo é altamente contagioso e exige medidas imediatas de controle para evitar surtos.

Espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês neste semestre.

Eu também aprendi ao longo desse processo.

Boa sorte no OSCE e muito sucesso na vida, sempre.

No que eu puder ajudar, estou a disposição.

Com carinho,

Marysoll.